

QUEM CONDUZ ESTA AULA

Apresentação do instrutor



INSTRUTOR

1º TEN QOCBM

GERALDO

Oficial Bombeiro Militar

Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco —
CBMPE

Especialista em APH e Resgate



Formação

Engenharia Química — Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)



Especialização

Pós-graduação em Atendimento Pré-Hospitalar (APH) e Resgate



Atuação

Oficial do CBMPE — prevenção, instrução e resposta a emergências



Proposta desta aula

Transformar o público geral — famílias, educadores e trabalhadores — na primeira linha de prevenção dentro de casa.

ROTEIRO DA AULA

Cinco módulos, dois casos simulados e um quiz final

01



O CENÁRIO

Por que a casa é o lugar dos acidentes

02



QUEDAS

Idosos e crianças · prevenção · Caso 1

03



INTOXICAÇÕES

Produtos de limpeza e remédios · Caso 2

04



CORTES

Vidro na cozinha e área de serviço

05



ENGASGO

Peças pequenas, moedas, baterias botão

06



QUIZ E SÍNTESE

5 questões comentadas · ações que salvam vidas

Como vamos trabalhar: cada módulo traz o risco, a prevenção e a conduta de primeiros socorros para quem não tem treinamento formal — sempre com a fonte oficial indicada no rodapé.

O TAMANHO DO PROBLEMA

Quedas: uma epidemia silenciosa dentro de casa

MORTES POR QUEDA

684 mil

por ano no mundo — 2ª maior causa de morte por lesão não intencional (OMS)



QUEDAS GRAVES

37,3 mi

por ano exigem atendimento médico no mundo (OMS)



IDOSOS ACIMA DE 65

1 em 3

cai ao menos uma vez por ano; após os 80, cerca de 40% (MS / INTO)



ACIMA DE 75 ANOS

7 em 10

mortes acidentais são provocadas por quedas (Ministério da Saúde)



O risco mora onde nos sentimos seguros

A maior parte das quedas de idosos acontece dentro de casa — no trajeto do quarto ao banheiro, no banho, na escada. Por isso a prevenção começa pela casa, e não pelo hospital.

QUEM ESTÁ EM RISCO?

Três perfis, riscos diferentes dentro da mesma casa



GRUPO 1

Idosos (60+)

- Perda de força muscular e de equilíbrio
- Visão reduzida e óculos desatualizados
- Uso de vários remédios (para dormir, pressão)
- Ossos frágeis (osteoporose): queda simples vira fratura
- Levantar à noite para ir ao banheiro



GRUPO 2

Crianças (0–9 anos)

- Curiosidade: exploram, escalam, abrem tudo
- Cabeça proporcionalmente maior: caem de cabeça
- Não percebem o perigo da altura
- Levam objetos e líquidos à boca
- Imitam adultos (garrafas, remédios)



GRUPO 3

Adultos no trabalho doméstico

- Escadas e bancos improvisados para alcançar objetos
- Vidro e facas na cozinha e na área de serviço
- Mistura de produtos de limpeza (gases tóxicos)
- Pressa e piso molhado

Regra prática: adapte a casa ao morador mais vulnerável — o que protege o idoso e a criança protege todos.

COMO UMA QUEDA MACHUCA

Nem toda queda é igual: altura, superfície e ponto de impacto



TIPO 1

Queda da própria altura

- Tropeço ou escorregão, com a pessoa em pé
- Parece banal — mas em idoso pode causar fratura de fêmur, de punho e trauma de crânio



TIPO 2

Queda de nível (de altura)

- Escada, laje, telhado, janela, beliche
- Bebês: trocador, cama e sofá — basta um segundo de distração

O que define a gravidade da queda (cinemática do trauma):

Altura

Adulto acima de 6 m ou criança acima de 3 m (2-3× a própria altura) = queda de alto risco

Superfície de impacto

Piso de cerâmica ou concreto transmite muito mais energia que grama ou colchão

Parte do corpo que bate

Cabeça, quadril e punho são os pontos mais atingidos — e os mais perigosos

AS LESÕES QUE NÃO APARECEM

Fratura de fêmur e trauma de crânio: reconheça os sinais



SUSPEITE DE

Fratura de fêmur (quadril)

- Dor forte na virilha ou no quadril
- Não consegue ficar de pé nem apoiar a perna
- Perna mais curta e virada para fora
- Principal motivo de internação após queda em idosos



SUSPEITE DE

Trauma de crânio "oculto"

- Sinais podem surgir horas ou dias depois
- Dor de cabeça que piora, vômitos repetidos
- Sonolência, confusão, fala enrolada
- Fraqueza de um lado do corpo



Atenção redobrada

Idoso que usa remédio para "afinar o sangue" (anticoagulante) e bateu a cabeça deve ser avaliado em serviço de saúde, mesmo que pareça bem.

FATORES DE RISCO PARA QUEDAS

Parte do risco está na pessoa, parte está na casa — os dois se corrigem

Fator de risco	Exemplos	Como reduzir
Medicamentos	Remédios para dormir, para pressão, muitos remédios ao mesmo tempo	Revisar a lista com o médico periodicamente
Visão e audição	Catarata, óculos desatualizados	Exame de vista anual
Força e equilíbrio	Sedentarismo, perda de massa muscular	Atividade física com treino de equilíbrio
Calçados	Chinelo aberto, sola lisa, andar de meias	Calçado fechado com sola antiderrapante
Ambiente	Tapetes soltos, fios no chão, pouca luz, piso molhado	Adaptar a casa (próximos slides)
Pressa noturna	Levantar rápido para ir ao banheiro	Sentar na cama por alguns segundos antes de levantar

CASA SEGURA: 5 MEDIDAS ESSENCIAIS

O que mais reduz quedas no ambiente doméstico

1



Iluminação noturna

Luz de presença no trajeto quarto → banheiro e interruptor ao lado da cama

2



Sem tapetes soltos

Retire tapetes, capachos e fios do caminho — ou fixe com antiderrapante

3



Barras de apoio

No box e ao lado do vaso sanitário; corrimão dos dois lados da escada

4



Piso antiderrapante

Tapete emborrachado no box; seque o chão molhado na hora

5



Telas e grades

Telas de proteção em janelas e sacadas; portão no topo e na base da escada

Baixo custo, alto impacto: são adaptações simples, que qualquer família pode fazer em um fim de semana.

CHECKLIST CÔMODO A CÔMODO

Uma vistoria de 15 minutos que evita uma internação

Cômodo	Verifique
Quarto	Interruptor ou abajur ao alcance da cama; cama na altura certa (pés apoiados no chão ao sentar)
Corredor	Caminho livre, sem tapetes, fios ou móveis; luz de presença ligada à noite
Banheiro	Barras de apoio, tapete antiderrapante no box, cadeira de banho se necessário
Cozinha	Itens de uso diário em altura fácil — nada de subir em banco ou cadeira
Escada	Corrimão firme nos dois lados, degraus sinalizados e bem iluminados
Janelas e sacadas	Telas de proteção; nenhum móvel encostado que a criança possa escalar



Faça a vistoria em família

Percorra a casa à noite, com a luz que o idoso usa, fazendo o mesmo trajeto que ele faz.



Regra prática

Se você precisa desviar de algo para passar, é ali que alguém vai tropeçar.

QUEDAS NA INFÂNCIA

O risco muda conforme a criança cresce

Faixa etária	Principais riscos de queda	Prevenção
0 a 1 ano	Trocador, cama, sofá, bebê-conforto sobre a mesa	Nunca deixar sozinho em superfície alta — nem por um segundo
1 a 4 anos	Escadas, janelas, móveis escaláveis	Portão de segurança, telas, móveis fixados na parede
5 a 9 anos	Lajes, muros, árvores, beliches	Supervisão, guarda-corpo em lajes e na cama de cima do beliche



Andador infantil: não use

A SBP desaconselha o andador: ele aumenta o risco de quedas, inclusive de escadas, e não ajuda a criança a andar.

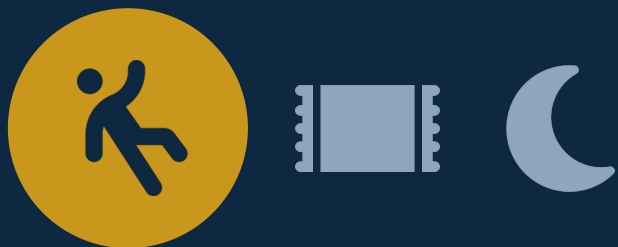


Janela não é brinquedo

Tela de proteção em todas as janelas e sacadas acima do térreo. Mosquiteiro não segura criança.

CASO 1 — A QUEDA NO CORREDOR

Tapete solto + corredor escuro + pressa noturna



CASO SIMULADO 1

Dona Luíza, 76 anos

Madrugada. Dona Luíza levanta para ir ao banheiro com o corredor escuro. Tropeça no tapete, cai de lado e não consegue se levantar: sente dor forte no quadril direito.

A filha acorda com o barulho e a encontra no chão, consciente e assustada. Dona Luíza toma remédio para pressão e pede para ser colocada na cama.

Discuta com a turma:

1

Devo atender ao pedido e colocá-la na cama?

2

Que sinais sugerem fratura de fêmur?

3

Quem chamar e o que informar?

CASO 1 — COMO AGIR COM SEGURANÇA

Decisão em três passos: cena, avaliação, conduta

1. Cena segura: acenda a luz e afaste obstáculos — não se machuque



2. Avalie: ela responde bem? Bateu a cabeça? Onde dói?



Dor forte no quadril ou não consegue se levantar?

↓ **SIM**

↓ **NÃO**

NÃO LEVANTE

Ligue 192. Mantenha-a imóvel na posição em que está, apoiada com travesseiros, aquecida com cobertor. Não dê comida, bebida nem remédio.

LEVANTAR COM TÉCNICA

Sem dor e sem lesão aparente: ajude-a a se levantar devagar (próximo slide) e observe nas 24–72 h seguintes.

AO LIGAR 192, INFORME:

- Endereço completo e ponto de referência
- Idade e o que aconteceu (queda da própria altura)
- Se bateu a cabeça ou desmaiou
- Onde dói e se consegue mexer a perna
- Remédios em uso (pressão, anticoagulante)



Enquanto o socorro não chega

Fique ao lado, converse e observe se ela continua respondendo bem. Se piorar, ligue de novo para o 192.

CASO 1 — O QUE FAZER E O QUE EVITAR

A resposta à pergunta: não, ela não deve ser colocada na cama

NÃO FAÇA



- Puxar pelos braços para levantá-la
- Colocá-la na cama "para ficar confortável"
- Dar remédio, comida ou água (pode precisar de cirurgia)
- Esperar amanhecer para pedir ajuda

FAÇA



- Ligar 192 imediatamente
- Cobrir com cobertor para evitar que perca calor
- Manter imóvel, apoiando com travesseiros ou rolos de toalha
- Ficar ao lado, tranquilizando, e separar documentos e remédios

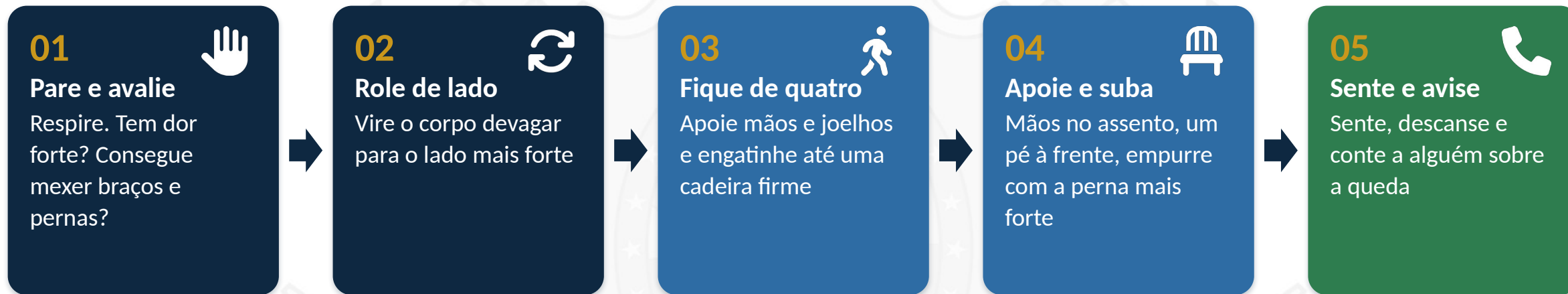


Tempo no chão também machuca

Ficar horas caído aumenta o risco de hipotermia, desidratação e lesão muscular. Idoso que mora só deve ter telefone ao alcance ou sistema de alerta.

COMO SE LEVANTAR APÓS UMA QUEDA

Quando não há lesão: técnica segura em 5 passos



Só use a técnica se não houver dor forte

Sentiu dor ao se mexer, bateu a cabeça ou não consegue apoiar a perna? Pare, fique aquecido e peça ajuda — ligue 192.

OS VILÕES DEBAIXO DA PIA

Intoxicações caseiras: produtos de limpeza e medicamentos



Produto	Onde costuma estar	Por que é perigoso
Água sanitária	Lavanderia	Irrita e queima boca e esôfago; misturada a outros produtos libera gás tóxico
Soda cáustica	Desentupidores	Queimadura grave e profunda do esôfago — emergência
Desinfetantes e limpadores	Banheiro e cozinha	Embalagens coloridas e cheirosas atraem crianças
Querosene e solventes	Área de serviço	Podem ir para o pulmão e causar pneumonia química
Medicamentos	Bolsa, mesa de cabeceira	Principal causa de intoxicação; doses pequenas já são perigosas para crianças
Raticidas clandestinos	Quintal	Intoxicação grave; "chumbinho" é proibido

A REGRA DE OURO DA INTOXICAÇÃO

Duas proibições e um número para salvar no celular

REGRA DE OURO 1



NUNCA
provoque vômito

REGRA DE OURO 2



NUNCA
dê leite, água, óleo ou receita
caseira sem orientação do CIATOX

DISQUE-INTOXICAÇÃO (CIATOX)

0800-722-6001

Ligação gratuita. Especialistas em toxicologia orientam o que fazer com aquele produto.



Em casa, a sequência é sempre a mesma

Pegue a embalagem → ligue para o CIATOX → siga a orientação. Se a pessoa estiver desacordada, com convulsão ou sem conseguir respirar: 192 imediatamente.

POR QUE O VÔMITO É PERIGOSO?

O caminho do corrosivo: o dano acontece duas vezes

01



Na ida

O produto corrosivo já queimou a boca, a garganta e o esôfago ao ser engolido.



02



Na volta

Ao vomitar, o produto passa de novo pelo mesmo caminho — a queimadura dobra.



03



No pulmão

Parte do líquido pode ser aspirada para o pulmão, causando pneumonia química — principalmente com querosene e solventes.



E o leite ou a água?

Dependendo do produto e da quantidade, oferecer líquido pode ajudar, não fazer diferença ou provocar vômito. Só o toxicologista, sabendo exatamente o que foi ingerido, pode indicar — por isso: ligue antes de dar qualquer coisa.

INTOXICAÇÃO: CONDUTA PASSO A PASSO

O que o público geral pode fazer com segurança



Afasto o produto

Retire a pessoa do local e limpe restos da boca com um pano, sem forçar



Pegue a embalagem

O rótulo diz o que foi ingerido — é a informação mais importante



Ligue 0800-722-6001

Informe produto, quantidade estimada, horário, idade e peso



Sinais graves? Ligue 192

Desacordado, convulsão, falta de ar, vômito com sangue



Leve a embalagem

Se for encaminhado ao hospital, a embalagem vai junto



Pele ou olhos atingidos

Retire roupas contaminadas e lave com água corrente abundante por pelo menos 15 minutos. Depois, ligue para o CIATOX.



Gás de produtos misturados

Saia do ambiente, abra portas e janelas e leve a pessoa para o ar livre.

CASO 2 — A GARRAFA ERRADA

Produto de limpeza em embalagem de bebida



CASO SIMULADO 2

Pedro, 3 anos

Domingo à tarde. Na área de serviço, uma garrafa PET de refrigerante guarda desinfetante comprado a granel. Pedro encontra a garrafa e bebe alguns goles. Ele começa a chorar e tossir. A mãe, em pânico, pensa em colocar o dedo na garganta dele para forçar o vômito.

Discuta com a turma:

1

A mãe deve provocar o vômito?

2

Qual o primeiro telefonema a fazer?

3

O que tornou esse acidente possível?

CASO 2 — A CONDUTA EXATA

Vomitando faria o desinfetante queimar o esôfago de Pedro pela segunda vez

O IMPULSO (ERRADO)

- Dedo na garganta para forçar o vômito
- Dar leite, água com sal ou óleo
- Esperar para "ver se passa"



A CONDUTA CORRETA

- Manter a calma e limpar a boca com um pano
- Pegar a garrafa e ligar 0800-722-6001 (CIATOX)
- Falta de ar, baba excessiva, vômito com sangue ou sonolência: 192
- Levar a garrafa ao serviço de saúde



A causa do acidente: a embalagem

Para uma criança, garrafa de refrigerante é bebida. Nunca guarde produto de limpeza fora da embalagem original — e evite produtos clandestinos vendidos a granel.

PREVENÇÃO DE INTOXICAÇÕES

Seis hábitos que tiram o veneno do alcance



Embalagem original

Nunca transfira produtos para garrafas de bebida



Nunca misture

Água sanitária com outros produtos libera gases tóxicos



No alto e trancado

Produtos de limpeza e remédios fora do alcance e da vista



Remédio não é doce

Não chame remédio de "docinho" nem tome na frente da criança



Produto regularizado

Prefira produtos com registro na Anvisa e tampa de segurança



Número salvo

Salve o 0800-722-6001 no celular de toda a família

CORTES PROFUNDOS COM VIDRO

Cozinha e área de serviço: controle rápido do sangramento

01



Proteja-se

Use luvas ou um saco plástico nas mãos e afaste os cacos de vidro



02



Comprima

Pressão direta e firme sobre o corte, com pano limpo ou gaze



03



Não alivie

Encharcou? Coloque outro pano por cima e continue apertando



04



Enfaixe

Parou? Faixa firme por cima do pano e procure atendimento



E a elevação do membro?

Pode ser associada, se não atrapalhar a compressão — mas sozinha não controla sangramento. A compressão direta é o que resolve.



Ligue 192 se:

O sangue sai em jato, não para após 10 minutos de pressão firme, há vidro encravado ou a mão perdeu movimento ou sensibilidade.

CORTES: O QUE NÃO FAZER

Receitas caseiras atrasam o socorro e aumentam a infecção

MITOS E ERROS PERIGOSOS



- Pó de café, açúcar, pasta de dente ou terra no corte
- Retirar vidro ou faca encravada
- Tirar o pano a toda hora "para ver se parou"
- Garrote improvisado com barbante ou fio

O QUE AS DIRETRIZES RECOMENDAM



- Objeto encravado: não retire; fixe com panos ao redor e comprima em volta
- Braço ou perna sangrando muito sem parar com pressão: torniquete (de preferência comercial) acima do corte, anote o horário e ligue 192
- Corte pequeno: lave com água corrente e sabão
- Mantenha a vacina antitetânica em dia



Prevenção

Recolha vidro quebrado com vassoura e pá (nunca com as mãos) e descarte embrulhado em jornal, identificado como "vidro".

PEQUENOS OBJETOS, GRANDE RISCO

Sufocação e aspiração de corpos estranhos em bebês e crianças

Peças pequenas

Brinquedos de crianças maiores, tampinhas, bolinhas de gude, ímãs



Moedas

O objeto engolido mais comum em crianças pequenas



Baterias botão

Controle remoto, balança, chave de carro, velas de LED, brinquedos



Alimentos

Uva inteira, salsicha em rodela, pipoca, amendoim, bala dura



Teste do rolo de papel higiênico



Se o objeto passa por dentro do tubo (cerca de 4 cm), pode engasgar uma criança menor de 3 anos. Mantenha fora do alcance.



Na cozinha

Corte uvas, tomates-cereja e salsichas no sentido do comprimento. Criança come sentada, sem correr ou brincar.

ENGASGO: A CONDUTA POR IDADE

Minutos contam — a ajuda começa antes de a ambulância chegar



BEBÊ MENOR DE 1 ANO

Não chora, não tosse, fica roxo

- Peça para alguém ligar 192
- 5 golpes firmes nas costas, entre as escápulas (bebê de bruços no antebraço, cabeça mais baixa)
- Vire e faça 5 compressões no centro do peito
- Repita até sair o objeto ou o bebê desmaiar



CRIANÇA A PARTIR DE 1 ANO

Não fala, não tosse, mão no pescoço

- Tossindo forte? Incentive a tossir e observe
- Não consegue tossir: 5 golpes nas costas + 5 compressões abdominais, alternando
- Peça para alguém ligar 192
- Desmaiou: deite no chão e inicie a RCP



Nunca faça a "varredura às cegas" com o dedo

Pode empurrar o objeto mais para dentro. Só retire o que estiver visível e fácil de pegar.

BATERIA BOTÃO: EMERGÊNCIA SILENCIOSA

Pequena, brilhante e corrosiva

BATERIA BOTÃO ENGOLIDA

2 horas

é o tempo em que uma bateria presa no esôfago já pode provocar queimadura grave — mesmo sem sintomas no início.



Suspeitou? Pronto-socorro já
Mesmo que a criança pareça bem



Não provoque vômito
E não dê comida nem bebida sem orientação



Leve o aparelho ou a embalagem
Ajuda a identificar o tipo e o tamanho da bateria



Previna
Tampa do compartimento parafusada; descarte baterias usadas fora do alcance

QUIZ — TESTE SEUS CONHECIMENTOS

Questões 1 e 2 • escolha uma alternativa

QUESTÃO 1 Dona Luíza caiu: dor forte no quadril, perna curta e virada para fora. O que fazer?

- A** Levantá-la e colocá-la na cama
- B** Não movimentar, aquecer e ligar 192
- C** Dar um analgésico e esperar
- D** Massagear o quadril para aliviar

QUESTÃO 2 Uma criança bebeu água sanitária. Qual a conduta correta?

- A** Provocar o vômito imediatamente
- B** Dar um copo de leite
- C** Ligar 0800-722-6001 com a embalagem em mãos
- D** Dar azeite ou óleo

QUIZ — TESTE SEUS CONHECIMENTOS

Questões 3 e 4 • escolha uma alternativa

QUESTÃO 3 Qual medida mais reduz quedas noturnas de idosos em casa?

- A** Encerar o piso do corredor
- B** Luz noturna e retirada de tapetes soltos
- C** Tapete felpudo ao lado da cama
- D** Andar de meias para não escorregar

QUESTÃO 4 Corte profundo na mão com vidro, sangrando muito. O primeiro passo é:

- A** Pó de café sobre o corte
- B** Compressão direta e firme com pano limpo
- C** Lavar 10 minutos antes de comprimir
- D** Garrote com barbante no punho

QUIZ — TESTE SEUS CONHECIMENTOS

Questão 5 • escolha uma alternativa

QUESTÃO 5 Bebê de 8 meses engasgado, consciente, sem chorar nem tossir. O que fazer?

A Compressões abdominais (Heimlich)

B Varredura às cegas com o dedo

C 5 golpes nas costas + 5 compressões no peito

D Virar de cabeça para baixo e sacudir



Hora de conferir

Anote suas respostas. No próximo slide, o gabarito comentado mostra o porquê de cada resposta, com a fonte oficial.

GABARITO COMENTADO

Cada resposta tem base em uma fonte oficial

Questão	Comentário	Fonte
1 — B	Suspeita de fratura de fêmur: não movimentar, aquecer e acionar o 192. Levantar agrava a lesão.	PHTLS 10ª ed. • MS
2 — C	Nunca provocar vômito nem dar leite sem orientação: o corrosivo queima de novo na volta.	CIATOX / Anvisa
3 — B	Iluminação no trajeto e ausência de tapetes soltos eliminam a principal causa de tropeço noturno.	MS • OMS
4 — B	A compressão direta e firme é a principal medida para controlar sangramento.	AHA / Cruz Vermelha 2024
5 — C	Em bebês: golpes nas costas + compressões no peito. Heimlich e varredura às cegas não.	AHA 2025

AÇÕES QUE SALVAM VIDAS

Síntese prática e canais de emergência



Ilumine e libere o caminho

Luz noturna, sem tapetes soltos, barras no banheiro



Idoso caiu com dor? Não levante

Aqueça, imobilize e ligue 192



Intoxicação? Nada de vômito

Embalagem na mão e 0800-722-6001



Sangrou? Aperte

Compressão direta e firme, sem aliviar



Engasgou? Costas e peito / abdome

Bebê: costas + peito • Criança: costas + abdome



SAMU

192



BOMBEIROS

193



CIATOX

0800-722-6001

FONTES OFICIAIS

Toda conduta apresentada está referenciada nestas instituições

Instituição	Documento de referência
Ministério da Saúde	Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa e Prevenção de Quedas — gov.br/saude
SBP	Departamento Científico de Segurança da Criança e do Adolescente — sbp.com.br
OMS / WHO	Falls — Fact Sheet e diretrizes de prevenção — who.int
PHTLS 10ª edição	Atendimento Pré-Hospitalar ao Traumatizado — Cinemática do trauma e quedas
CIATOX / Anvisa	Disque-Intoxicação 0800-722-6001 — gov.br/anvisa
AHA / Cruz Vermelha	Guidelines for First Aid 2024 e Diretrizes de RCP e ACE 2025 — ahajournals.org

Este conteúdo não substitui a avaliação de profissionais de saúde. Em emergência, ligue 192 ou 193.

